

INICIACIÓN A LA PRÁCTICA PROFESIONAL

MARCO TEÓRICO:

La discapacidad en el medio rural despoblado



Francisco José Gallego Moreno

3º CURSO 2025/2026
LABORATORIO INTEGRACIÓN
SOCIOLABORAL

Alicia Díaz-Pinto Tercero

ÍNDICE

1.- CONCEPTUALIZACIÓN.....	2
1.1.- La discapacidad como desafío de empleo en entornos rurales.....	3
2.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA.....	4
2.1.- El Modelo de Prescindencia: La exclusión por causas sagradas.....	4
2.2.- El Modelo Médico-Rehabilitador: De la caridad a la patología.....	4
2.3.- El Modelo Social: la discapacidad como opresión social.....	5
2.4.- El Modelo de Diversidad y Derechos Humanos (Siglo XXI).....	5
3.- DEMOGRAFÍA Y EPIDEMIOLOGÍA DE LA POBLACIÓN.....	5
3.1.- Grupos de población afectados.....	6
3.2.- Realidad Demográfica en el Medio Rural Despoblado.....	6
3.3.- Alcance Territorial: Alcarria Conquense.....	6
4.- CONSECUENCIAS PSICOSOCIALES Y SANITARIAS.....	7
4.1.- Factores de Riesgo: La vulnerabilidad estructural.....	7
4.2.- Factores de Protección: La resiliencia comunitaria.....	7
5.- POLÍTICA SOCIAL, SANITARIA Y EDUCATIVA.....	8
5.1.- Legislación y Desarrollo Reglamentario.....	8
5.2.- Financiación y Recursos Económicos.....	9
5.3.- Perspectiva Comparada Internacional.....	9
6.- SISTEMA DE ATENCIÓN.....	10
6.1.- Organizaciones y Entidades del Sistema.....	10
6.2.- Procedimientos de Intervención.....	11
6.3.- El papel de la Trabajadora social en el entorno rural.....	11
7.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	12
ANEXOS. Anexo 1: Mapa conceptual.....	14

1.- CONCEPTUALIZACIÓN.

La discapacidad es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un término genérico que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a la participación. Según esta definición, la discapacidad no es únicamente un atributo de la persona, sino el reflejo de la interacción entre las características del cuerpo humano y de la sociedad en la que vive. Esta perspectiva multidimensional es fundamental para comprender que la discapacidad ocurre cuando el estado de salud de una persona se encuentra con un entorno que no se adapta a sus necesidades (OMS, 2024).

Este concepto se basa en el Modelo Biopsicosocial, el cual desvía el foco del “déficit” individual hacia la “barrera” social. Bajo esta visión, la discapacidad se entiende como un proceso dinámico y no estático, donde la salud del individuo está en constante diálogo con factores contextuales, ambientales y personales que pueden facilitar o limitar su autonomía (OMS, 2024).

El Observatorio Estatal de la Discapacidad señala que la definición de medio rural viene establecida por la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural (LDSMR). Aquí se define el medio rural como una zona geográfica formada por municipios o entidades locales con una población inferior a 30.000 habitantes y una densidad menor a los 100 habitantes por km².

En el marco de mi Laboratorio de Integración Sociolaboral, esta definición se expande para incluir la empleabilidad como eje central. En el medio rural despoblado, la discapacidad se conceptualiza como una situación de exclusión sociolaboral que empeorada por factores territoriales. La baja densidad demográfica y la dispersión geográfica en zonas rurales no solo limitan la movilidad, sino que disminuyen de manera drástica el acceso a oportunidades en el mercado laboral adaptadas y a centros especiales de empleo, lo que genera una doble vulnerabilidad: por la condición de discapacidad y por el aislamiento del mercado laboral rural (Gallego Moreno y Lascorz Fumanal, 2025).

Desde la perspectiva del Trabajo Social, esta realidad se vincula directamente con la “Justicia Espacial”, que sostiene que el lugar de residencia no debería determinar el

acceso a derechos fundamentales. En las zonas en riesgo de despoblación, el entorno geográfico deja de ser un espacio neutro para transformarse en un factor de estratificación social, donde la ausencia de una masa crítica de población frena la inversión en recursos de apoyo laboral, perpetuando un ciclo de inactividad y dependencia económica (Gallego Moreno y Lascorz Fumanal, 2025).

1.1.- La discapacidad como desafío de empleo en entornos rurales.

Para una comprensión profunda desde la perspectiva multidisciplinar del Trabajo Social, el concepto debe analizarse a través de las siguientes dimensiones:

- **Restricción de Participación Laboral.** En un municipio con escaso tejido empresarial, la discapacidad se define por la falta de oportunidades reales de inserción, donde la ausencia de transporte público adaptado impide el desplazamiento hacia los centros de trabajo, transformando el aislamiento en una barrera laboral insalvable. Esta limitación se ve intensificada por la brecha digital en el medio rural, que limita la posibilidad de teletrabajo, herramientas que podrían eliminar la barrera física pero que requieren de infraestructuras tecnológicas que a menudo son deficientes en estos territorios (Gallego Moreno y Lascorz Fumanal, 2025).
- **Modelo Ecosocial y Comunitario.** Este enfoque entiende la discapacidad como el resultado de la interacción persona-entorno, orientando la intervención hacia la eliminación de barreras y el fomento de la inclusión social y laboral efectiva en la comunidad. Desde esta perspectiva, la intervención del trabajador social no debe limitarse a la persona con discapacidad, sino que debe actuar sobre los diferentes sistemas: desde el microsistema (familia y red de cuidados informales) hasta el macrosistema (políticas de desarrollo rural), buscando una cohesión que permita la sostenibilidad de los proyectos de vida en el pueblo (Gallego Moreno y Lascorz Fumanal, 2025).
- **Perspectiva de la Interseccionalidad.** Resulta imprescindible entender que la discapacidad en el entorno rural presenta una gran diversidad de realidades que no debe abordarse como un fenómeno uniforme. El concepto se define también por el cruce de diversas categorías de opresión: ser mujer, tener edad avanzada o carecer de formación técnica específica en un entorno de baja densidad de población genera una “triple exclusión”. En el Laboratorio de Integración

Sociolaboral, la interseccionalidad nos permite identificar que las mujeres del medio rural con discapacidad se enfrentan a mayores tasas de inactividad debido al mantenimiento de los roles de género y a la carga de cuidados familiares que recaen sobre ellas (Gallego Moreno y Lascorz Fumanal, 2025).

2.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA.

La historia de la discapacidad no es un proceso lineal, sino una sucesión de rupturas en la forma en que la sociedad percibe la diferencia. La evolución se puede dividir en etapas clave que han constituido la posición del colectivo en la estructura social.

2.1.- El Modelo de Prescindencia: La exclusión por causas sagradas.

En las sociedades antiguas y hasta bien entrada la Edad Media, la discapacidad se veía desde una dimensión transcendente. Las causas eran externas al hombre: un castigo divino o una posesión demoníaca (Palacios, 2008).

- **La eugenesia antigua.** En las poblaciones como Esparta o la Roma de las Doce Tablas, el origen de la discapacidad justificaba el infanticidio (eugenesia), pues se entendía que estas personas no podían servir para fines militares o productivos del Estado (Ferreira, 2010).
- **La marginación caritativa.** Con el cristianismo, se cambió del exterminio a la piedad. La persona con discapacidad (PCD) pasa a ser un objeto de caridad que deja al “sano” ejercer la benevolencia, pero permanece excluida de la vida comunitaria y laboral, sobreviviendo en los márgenes de la exclusión social (Romañach y Lobato, 2005).

2.2.- El Modelo Médico-Rehabilitador: De la caridad a la patología.

En este modelo, la discapacidad pasa de ser un castigo divino para entenderse como una patología biológica que debe ser curada para llegar a la funcionalidad (Oliver, 1990).

- **Productividad industrial.** Con la Revolución Industrial, la discapacidad se redefine como incapacidad laboral. El cuerpo que no es capaz de seguir el ritmo de la fábrica es etiquetado como “inválido” y marginado en las instituciones (Barnes, 1998).

MARCO TEÓRICO: LA DISCAPACIDAD EN EL MEDIO RURAL DESPOBLADO

- **Rehabilitación y normalización.** Tras las Guerras Mundiales, el objetivo se centra en la reintegración del mutilado. El éxito se mide por la capacidad del sujeto de “parecer normal” y ser productivo, dando al profesional médico un control absoluto sobre su autonomía (OMS, 2011).

2.3.- El Modelo Social: la discapacidad como opresión social.

A finales de los 60, motivado por movimientos como la UPIAS (Unión de Personas con Deficiencias Físicas contra la Segregación), surge un cambio de perspectiva: la discapacidad no es una condición biológica, sino el resultado de una sociedad organizada únicamente para personas “estándar” (UPIAS, 1976).

- **Deficiencia vs. Discapacidad.** Este modelo diferencia entre la deficiencia (característica física o sensorial) y la discapacidad (barreras sociales que impiden la participación). Es el entorno el que discapacita al individuo (Oliver, 1990).
- **Evolución del Trabajo Social.** La profesión va desde el asistencialismo al empoderamiento. El rol del trabajador social se redefine: ya no busca “curar”, sino terminar con las barreras ambientales y defender los derechos civiles y la autonomía de la persona (Ferreira, 2010).

2.4.- El Modelo de Diversidad y Derechos Humanos (Siglo XXI).

En el siglo XXI, la discapacidad se integra en la Perspectiva de Derechos Humanos y el Modelo de Diversidad, comprendiéndose como una característica propia a la condición humana, equiparable al género o la etnia (Romañach y Lobato, 2005).

- **Precedentes Normativos.** La Convención de la ONU de 2006 establece un mandato internacional obligatorio que impone a los Estados garantizar completa inclusión y el derecho al empleo (Naciones Unidas, 2006).
- **Territorialización Rural.** El enfoque actual intenta corregir la histórica concentración urbana de recursos mediante la descentralización de servicios. El objetivo es prevenir que el medio rural actúe como un factor de exclusión, garantizando la equidad territorial en el acceso a derechos (García y Martínez, 2021).

3.- DEMOGRAFÍA Y EPIDEMIOLOGÍA DE LA POBLACIÓN.

La discapacidad no es un grupo homogéneo; su frecuencia y necesidades cambian según el tipo de deficiencia y el entorno donde se encuentra la persona. A nivel mundial, la OMS valora que el 16% de la población vive con alguna discapacidad, cifra que en España supera los 4 millones de personas. En Castilla-La Mancha, esta realidad supera las 205.000 personas, con una prevalencia regional asociada al envejecimiento y la ruralidad, donde más del 60% de los afectados tiene una edad mayor a los 60 años (OMS, 2024, Instituto Nacional de Estadística (INE), 2022; Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha).

3.1.- Grupos de población afectados.

La discapacidad se puede clasificar fundamentalmente en cuatro grandes áreas atendiendo a la naturaleza de la limitación:

- **Física.** Afecta a la movilidad o sistemas orgánicos, siendo la más frecuente en personas de edad avanzada (INE, 2022).
- **Intelectual.** Relacionada con el desarrollo cognitivo y la conducta adaptativa (Gallego Moreno y Lascorz Fumanal, 2025).
- **Sensorial.** Limitaciones en alguno de órganos de los sentidos que pueden dificultar la comunicación (INE, 2022).
- **Psicosocial.** Trastornos de salud mental que afectan la interacción social (Martínez-Ríos, 2020).

3.2.- Realidad Demográfica en el Medio Rural Despoblado.

El impacto de la discapacidad se ve empeorado en zonas con riesgo de despoblación debido a factores demográficos estructurales que influyen en la vida de los ciudadanos. La baja densidad demográfica impide a menudo la existencia de servicios especializados cercanos, mientras que la dispersión geográfica obliga a hacer largos trayectos para acceder a recursos básicos de salud o empleo.

A nivel nacional, los datos del Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) permite expandir la magnitud de esta realidad. En España, residen aproximadamente 944.442 personas con discapacidad en el medio rural, lo que supone el 24,9% del total del

MARCO TEÓRICO: LA DISCAPACIDAD EN EL MEDIO RURAL DESPOBLADO

colectivo en el país. Esta relevancia cuantitativa se puede ver en una tasa de prevalencia del 10,4%, una cifra que supera la media de la población general.

Asimismo, el envejecimiento de la población rural genera una pirámide invertida donde la discapacidad física y sensorial conseguida por la edad es la norma, generando una mayor demanda de servicios de dependencia en municipios con escasos recursos (García y Martínez, 2021; Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM), 2021). Según la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha se distingue “zonas de extrema despoblación” cuando la densidad es menor a 8 habitantes por km², lo que establece el escenario de mayor aislamiento para la prestación de servicios.

4.- CONSECUENCIAS PSICOSOCIALES Y SANITARIAS.

Como ya hemos mencionado anteriormente, la interacción entre la discapacidad y el medio rural despoblado genera una “doble vulnerabilidad” que afecta tanto la salud física como la estabilidad emocional. Las barreras del entorno no solo frenan la movilidad, sino que impiden la participación social y laboral, generando situaciones de desigualdad o exclusión social (García y Martínez, 2021).

4.1.- Factores de Riesgo: La vulnerabilidad estructural.

Estos son condiciones que generan una mayor probabilidad de exclusión y deterioro de la calidad de vida:

- **Escasez de servicios sociosanitarios y educativos.** La escasa accesibilidad a recursos básicos y servicios especializados en el territorio impide la atención continuada (Martínez-Píos, 2020).
- **Falta de transporte público adaptado.** La ausencia de una red de transporte que comunique los municipios dificulta el acceso a centros de salud y empleo, transformándose en una barrera insalvable (Comisión Europea, 2021).
- **Aislamiento y exclusión.** La baja densidad demográfica y dispersión geográfica favorecen la marginación del colectivo y el riesgo de soledad (OMS, 2024).

4.2.- Factores de Protección: La resiliencia comunitaria.

Son elementos que actúan como amortiguadores y promueven la permanencia en el territorio:

- **Redes familiares y comunitarias.** El apoyo de las familias cuidadoras y personas implicadas es el soporte principal en zonas con escasos servicios formales (Palacios, 2008).
- **Iniciativas de sensibilización.** Proyectos que dan visibilidad al colectivo y recogen testimonios ayudan a romper con esa marginación y aseguran las necesidades básicas (Gallego Moreno y Lascorz Fumanal, 2025).
- **Mapeo y planificación.** La identidad de recursos sociosanitarios y educativos existentes permite mejorar la planificación de políticas públicas (Ley 2/2021).

5.- POLÍTICA SOCIAL, SANITARIA Y EDUCATIVA.

Abordar la discapacidad en entornos rurales requiere una estructura normativa que combine la protección de derechos fundamentales con estrategias específicas de cohesión territorial. Este soporte se organiza desde la escala europea hasta la local, con un enfoque progresivo hacia la autonomía personal y la inserción sociolaboral.

5.1.- Legislación y Desarrollo Reglamentario.

El marco jurídico actual se basa en la superposición de niveles administrativos que garantizan la equidad en el acceso a servicios:

- **Nivel Nacional.** El pilar fundamental es el Real Decreto Legislativo 1/2013, que establece el derecho a la igualdad de oportunidades y la no discriminación. Esta ley es la que permite exigir que cualquier medida sanitaria o educativa sea accesible sin importar la condición de salud del ciudadano (Real Decreto Legislativo 1/2013, 2013).
- **Nivel Regional.** En el contexto de Catilla-La Mancha, la Ley 2/2021 frente a la Despoblación es la norma más original, ya que introduce la obligatoriedad de la “discriminación positiva”. Esto quiere decir que la administración debe interferir más en municipios como los de la Alcarria Conquense para contrarestar los costes

que la dispersión geográfica produce en la prestación de servicios (Ley 2/2021, 2021).

- **Planes Sectoriales.** La intervención se guía por la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2021-2030, la cual marca la hoja de ruta para la desinstitucionalización. El objetivo es que la política social deje a la persona estar en su domicilio con los apoyos necesarios, en lugar de ser trasladada a centros urbanos marginados (Comisión Europea, 2021).

5.2.- Financiación y Recursos Económicos.

La financiación de estas medidas es mixta y se organiza a través de varias partidas presupuestarias:

- **Distribución de recursos.** Los fondos son generados principalmente por los presupuestos regionales de Bienestar Social y Sanidad, complementados por fondos europeos (como el FSE+). En Castilla-La Mancha, la Ley 2/2021 asegura que una parte del presupuesto regional vaya directamente a zonas rurales para asegurar que la atención temprana y la ayuda a domicilio lleguen a núcleos con baja densidad (Ley 2/2021, 2021).
- **Inversión en Empleo.** A través de entidades como el SEPE y las consejerías de empleo, se destinan subvenciones específicas para el mantenimiento de Centros Especiales de Empleo y para motivar la contratación de personas con discapacidad en municipios de riesgo de despoblación, buscando rectificar la brecha de empleabilidad rural (Gallego Moreno y Lascorz Fumanal, 2025).

5.3.- Perspectiva Comparada Internacional.

El abordaje de la discapacidad en el medio rural varía notablemente entre países:

- **Modelos Nórdicos (Suecia/Noruega).** Usan un sistema de “servicios universales de proximidad” muy técnicos (teleasistencia avanzada y transporte a demanda) que asegura que no existan distinciones entre lo rural y lo urbano (Comisión Europea, 2021).
- **Modelos de Países en Vías de Desarrollo.** La tendencia actual de Rehabilitación Basada en la Comunicación (RBC), donde, ante la falta de amplios hospitales, se forma a agentes comunitarios y familias para realizar la intervención en el propio territorio (OMS, 2024).

6.- SISTEMA DE ATENCIÓN.

El sistema de atención en entornos rurales despoblados se basa en una red de colaboración público-privada que busca garantizar la calidad de vida y la permanencia de las personas con discapacidad en su entorno de origen. Debido a la dispersión geográfica y la baja densidad de población, el sistema debe ser flexible y proactivo, trasladando los recursos hacia los municipios para evitar la institucionalización y fomentar la autonomía personal. Esta estructura de atención se basa en un enfoque comunitario y Ecosocial que comprende la discapacidad como el resultado de la interacción entre la persona y las barreras de su entorno rural (García y Martínez, 2021; Palacios, 2008).

6.1.- Organizaciones y Entidades del Sistema.

La respuesta frente a las necesidades del colectivo en zonas rurales se articula a través de distintos agentes que operan de forma coordinada para superar las limitaciones del territorio:

- **Administración Pública.** Los servicios sociales de los ayuntamientos y las mancomunidades rurales constituyen la puerta de entrada al sistema, gestionando las prestaciones básicas, la valoración de la dependencia y la ayuda a domicilio (JCCM, 2021).
- **Entidades del Tercer Sector.** Organizaciones como AMIAB, especializada en la inclusión sociolaboral, y el CEDER, centrado en el desarrollo rural, actúan como motores de transformación para implementar programas específicos de sensibilización y apoyo que complementan la acción pública en áreas donde el Estado tiene menor presencia física (Gallego Moreno y Lascorz Fumanal, 2025).
- **Instituciones Académicas.** La universidad tiene un papel de apoyo técnico mediante la investigación aplicada y la realización de diagnósticos territoriales que dejan aplicar las políticas de intervención con datos actualizados sobre la población rural (Gallego Moreno y Lascorz Fumanal, 2025).
- **Redes Comunitarias.** En entornos con escasos servicios formales, las redes de apoyo vecinal y la familia extensa se transforman en un pilar esencial del sistema de atención, actuando como el primer nivel de protección informal y soporte emocional (Palacios, 2008).

6.2.- Procedimientos de Intervención.

La metodología de intervención en territorios rurales con riesgo de despoblación necesita procedimientos concretos que garanticen la eficacia de las medidas y la optimización de los pocos recursos disponibles:

- **Diagnóstico Social Participativo.** Se fundamenta en la implicación activa de las personas con discapacidad y los agentes del territorio para reconocer las barreras reales desde la propia comunidad, evitando soluciones estandarizadas que no funcionan en el mundo rural (Gallego Moreno y Lascorz Fumanal, 2025).
- **Mapeo de Recursos.** Su finalidad es la identificación y registro sistemático de los activos sociosanitarios, educativos y de movilidad existentes para identificar “vacíos” prestacionales y diseñar rutas de atención que minimicen el impacto de la distancia geográfica (García y Martínez, 2021).
- **Diseño de Instrumentos Técnicos.** El uso de cuestionarios y herramientas de recogida de información permite cuantificar el impacto de la discapacidad en las familias y orientar la planificación de los servicios públicos basados en la evidencia (INE, 2022).

6.3.- El papel de la Trabajadora social en el entorno rural.

La figura de la Trabajadora Social es el eje fundamental del sistema de atención en el medio rural, ejerciendo funciones variadas que son muy importantes para la cohesión social:

- **Detección e Identificación.** Se encarga de encontrar a personas en situación de invisibilidad o aislamiento que no pueden optar a los recursos por falta de información, miedo al estigma o limitaciones en el transporte adaptado (Martínez-Ríos, 2020).
- **Mediación y Coordinación.** Actúa como un enlace entre los diferentes niveles del sistema (ayuntamiento, servicios sanitarios y entidades del tercer sector), favoreciendo que los apoyos lleguen de forma efectiva a pesar de la dispersión de los núcleos de población (Gallego Moreno y Lascorz Fumanal, 2025).
- **Promoción de la Autonomía.** Trabaja en el empoderamiento de la persona para que desarrolle su proyecto de vida en el pueblo, coordinando los servicios de

proximidad y las adaptaciones necesarias para promover la vida autónoma (Comisión Europea, 2021).

- **Defensa de la Equidad Territorial.** La profesional debe mirar por el cumplimiento de los principios de discriminación positiva, pidiendo que la inversión y los recursos se repartan de forma equitativa para compensar las desventajas estructurales de las zonas despobladas (Ley 2/2021, 2021).

7.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y OTRAS FUENTES CONSULTADAS.

Barnes, C. (1998). *The Social Model of Disability: A Mythical Beast?*. Disability & Society.

Comisión Europea. (2021). *Unión de la Igualdad: Estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad 2021-2030*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0101>

Comisión Europea. (2021). *Unión de la Igualdad: Estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad 2021-2030*.

Ferreira, M. A. V. (2010). *De la minusvalía a la diversidad funcional: un nuevo marco teórico-metodológico*. Siglo Cero.

Gallego Moreno, F. J., y Lascorz Fumanal, A. (2025). *DISRURAL: Diagnóstico de la discapacidad en el medio rural despoblado [Proyecto de investigación aplicada]*. Universidad de Castilla-La Mancha.

García, M. y Martínez, J. (2021). *Discapacidad y entorno rural: Retos de la intervención social en la España despoblada*. Editorial Social.

Instituto Nacional de Estadística. (2022). *Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD 2020)*.

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (2021). *Ley 2/2021 frente a la Despoblación en Castilla-La Mancha*.

Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha. *Diario Oficial de Castilla-La Mancha*, 108, de 12 de mayo de 2021.

MARCO TEÓRICO: LA DISCAPACIDAD EN EL MEDIO RURAL DESPOBLADO

- Martínez-Ríos, B. (2020). *Interseccionalidad y discapacidad: Un análisis desde el Trabajo Social*. Revista de Servicios Sociales.
- Naciones Unidas. (2006). *Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad*.
- Observatorio Estatal de la Discapacidad. (2017). *Las personas con discapacidad residentes en el Medio Rural: situación y propuestas de acción*. Ediciones del OED. <http://www.observatoriodeladiscapacidad.info>
- Oliver, M. (1990). *The Politics of Disablement*. Macmillan Education.
- Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2011). *Informe mundial sobre la discapacidad*.
- Organización Mundial de la Salud. (2024). *Discapacidad*. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health>.
- Palacios, A. (2008). *El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad*. CERMI.
- Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. *Boletín Oficial del Estado*, 289, de 3 de diciembre de 2013.
- Romañach, J. y Lobato, M. (2005). *Diversidad funcional, nuevo término para la lucha por la dignidad en la diversidad del ser humano*. Foro de Vida Independiente.
- UPIAS. (1976). *Fundamental Principles of Disability*. Union of the Physically Impaired Against Segregation.

ANEXOS

Anexo 1: Mapa conceptual.

